

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-05

Toegewezen casussen: **C09** (27-jarige salesvertegenwoordiger) en **C10** (52-jarige operationeel directeur)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX)
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)	8
4	Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-predictoren	14
6	Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

Het PHOENIX-systeem en de context van deze studie

PHOENIX (Personalized Hierarchical Optimization Engine for Navigating Insightful eXplorations) is een multi-agentsysteem ontwikkeld als onderdeel van een masterproef in de psychologie aan de Universiteit Gent. Het systeem verwerkt een vrije klachttekst en doorloopt vijf opeenvolgende klinische redeneerstappen die de kern vormen van een gepersonaliseerde, longitudinale digitale interventie.

Het theoretische kader van PHOENIX steunt op het **netwerk-analytisch model van psychopathologie** (Borsboom & Cramer, 2013): psychische klachten worden niet als uitingen van een latente stoornis beschouwd, maar als een *dynamisch netwerk van onderling samenhangende klachtcomponenten*. Een sleutelbegrip daarbinnen is het onderscheid tussen **criteria** (symptoomdimensies die de toestand van de persoon beschrijven) en **predictoren** (modificeerbare variabelen die de criteria causaal beïnvloeden en als behandeldoel kunnen dienen).

Kerndefinities: criterium versus predictor

Criterium (CR): een klinisch relevante, momentaan aanwezige *klacht- of toestandsdimensie* van de persoon die herhaald meetbaar is via dagelijkse EMA. Criteria zijn de *uitkomstvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat er mis gaat* (bijv. inslaapproblemen, paniekepisoden, sombere stemming). Criteria zijn geen gedragingen of interventies.

Predictor (P): een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die plausibel causaal ingrijpt op een of meerdere criteria en dagelijks meetbaar is via een korte EMA-vraag. Predictoren zijn de *ingreepvariabelen* in het netwerk – ze beschrijven *wat veranderbaar is* (bijv. avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging). Een predictor is *nooit een symptoom zelf*, maar een gedrag, strategie of omgevingsfactor die het symptoom beïnvloedt.

Voorbeelden ter verduidelijking:

- **Criterium:** inslaapproblemen, anticipatieangst, anergie, guilt-driven ruminatie.
- **Predictor:** avondschermtijd (min), geplande exposurestap (ja/nee), bewegingsfrequentie (min), preslaap-offloading (ja/nee).
- **Geen predictor, geen criterium:** eetlust bij avondmaal, rusthartslag, spierspanning – dit zijn symptoom- of toestandsmaten, geen behandelbare predictoren.

Ecological Momentary Assessment (EMA) – basisprincipes

EMA is een methode waarbij personen meerdere keren per dag hun actuele toestand of gedrag rapporteren via een mobiele applicatie. In PHOENIX wordt EMA gebruikt om zowel criteria als predictoren dagelijks te monitoren over een periode van meerdere weken.

Een goede EMA-variabele voldoet aan vier vereisten:

- **Dagelijks rapporteerbaar:** via een korte vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10).
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste trek, diagnose of stabiel achtergrondkenmerk.
- **Klinisch relevant:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.
- **Onderscheid criterium vs. predictor:** symptoomdimensies zijn criteria; modificeerbare gedragingen zijn predictoren.

Het bipartiet netwerk: structuur van het observatiemodel

Na 21 dagen EMA-monitoring construeert PHOENIX een **bipartiet netwerk**: een graaf met twee kolommen sets en gewogen verbindingen daartussen.

- **Linkse kolom – Predictoren (P)**: de modificeerbare variabelen.
- **Rechtse kolom – Criteria (CR)**: de klacht- en toestandsdimensies.
- **Kanten**: de richting loopt van predictor naar criterium ($P \rightarrow CR$). Een *blauwe* rand duidt op een positief verband (predictor vergroot het criterium), een *rode* rand op een negatief verband (predictor verkleint het criterium). Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van het empirische verband uit de monitoringdata.

In **Deel 3** rangschikt u de predictoren op behandelprioriteit op basis van dit netwerk en de monitoringsamenvatting.

Overzicht van de vijf taken

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
1	Operationalisering	Identificeer 2–6 criteriumlabels (klacht-dimensies)	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 predictorlabels (modificeerbaar, EMA-geschikt)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik alle 5 predictoren van hoog naar laag behandelprioriteit	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 6 EMA-items (2 per behandeldoel) uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			35–45 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren en vergelijkbaar zijn.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blinde beoordeling.

2 Deel 1: Operationalisering van de mentale gezondheidstoestand

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele klacht- en toestandsdimensies (**criteria**) in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

Wat is een criterium? Een criterium is een *symptoom- of klachtdimensie* die beschrijft *wat er mis gaat* bij de persoon. Het is *geen* behandeling, geen gedrag en geen oorzaak, maar een actuele toestandsbeschrijving:

- momenteel aanwezig bij de persoon (niet hypothetisch of anamnestic),
- onderscheidbaar van andere klachtdimensies (niet overlappend),
- in principe herhaald meetbaar via dagelijkse zelfrapportage (EMA).

Voorbeelden van goede criteriumlabels: inslaapproblemen, paniekepisoden, anticipatieangst, sombere stemming, emotionele uitputting, anergie, interpersoonlijke instabiliteit, compulsief controlegedrag.

Let op: gedragingen (bijv. “avondschermtijd”), oorzaken (bijv. “werkstress”) en behandelstrategieën zijn *geen* criteria maar predictoren – die horen in Deel 2.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger

“Mijn stemming kan op een dag heel snel omslaan en vaak lijkt dat sterker dan wat er feitelijk gebeurt. Ik kan mij in de ochtend nog redelijk voelen en tegen de middag helemaal ontredderd zijn. Wanneer ik mij bekritiseerd of afgewezen voel, zelfs om iets kleins, reageer ik extreem heftig – boos of heel wanhopig. Ik handel ook impulsief, vooral met geld of in relaties, en heb daar achteraf spijt van. Mijn relaties worden vaak snel intens en lopen daarna mis. Ik zie dat dat patroon zich herhaalt, maar ik weet niet hoe ik het moet doorbreken.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 6 Label (2–5 woorden): _____

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur

“De werkstress is het grootste deel van het afgelopen jaar blijven oplopen. Ik heb voortdurend spanning-shoofdpijn en mijn maag is op de meeste dagen ontregeld. 's Nachts lig ik wakker over werkproblemen en beslissingen die nog genomen moeten worden, en als ik eenmaal wakker ben geraakt, val ik vaak niet meer in slaap. Ik drink bijna elke avond twee of drie glazen wijn om tot rust te komen. Ik weet dat dat niet ideaal is, maar het voelt alsof ik anders niet kan afschakelen. Mijn beweging is volledig weggevallen en ik snap thuis sneller dan vroeger.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 6 Label (2–5 woorden): _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel (bipartiet netwerk)

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5 predictorlabels** die samen het **initieel observatiemodel** voor deze casus vormen.

Wat is een predictor in deze context? Een predictor is een *modificeerbare gedrags- of procesvariabele* die beschrijft *wat de persoon kan veranderen*:

- **Modificeerbaar:** de persoon (of therapeut) kan er rechtstreeks op ingrijpen.
- **EMA-geschikt:** dagelijks meetbaar via een eenvoudige vraag op de smartphone (ja/nee, aantal, minuten of 0–10 schaal).
- **Causaal plausibel:** klinisch aannemelijk dat het predictor de criteria beïnvloedt.
- **Geen criterium:** symptomen, klachtniveaus of diagnostische trekken zijn *geen* predictoren.

Voorbeelden van goede predictorlabels: avondschermtijd, geplande exposure, aerobe beweging, preslaap-offloading, veiligheidsgedrag, werk-privegrens, herstelactiviteit, compulsie-uitstel.

Let op: predictoren als “eetlust”, “spierspanning” of “moeheid” zijn symptoomdimensies (criteria) – geen predictoren. Kies variabelen die de persoon actief kan uitvoeren of aanpassen.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 2

27-jarige salesvertegenwoordiger; duur: 3 jaar. Snelle stemmingsschommelingen, uitgesproken afwijzingsreactiviteit, impulsief gedrag en relationele instabiliteit.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Snelle stemmingsschommelingen
- **CR-2** Afwijzingsreactiviteit
- **CR-3** Impulsief gedrag
- **CR-4** Relationele instabiliteit

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 2

52-jarige operationeel directeur; duur: ongeveer 9 maanden. Chronische werkstress, doorslaapinsomnie, somatische stressklachten en alcoholgebruik als coping.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Chronische werkstress
- **CR-2** Doorslaapinsomnie
- **CR-3** Somatische stressklachten
- **CR-4** Alcohol als copingstrategie

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

4 Deel 3: Behandeldoelprioritering via het bipartiet netwerk

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** behandelprioriteit.

Wat is een behandeldoel? Een behandeldoel is de predictor die, als hij veranderd wordt, naar verwachting de sterkste vermindering van de criteria oplevert. U selecteert op basis van drie criteria:

- a) **Bewijs uit monitoring:** is er in de monitoringdata aanleiding dat deze predictor actief bijdraagt aan de klacht (bijv. hoge frequentie van problematisch gedrag, of bijna afwezigheid van gewenst gedrag)?
- b) **Klinische modificeerbaarheid:** is de predictor realistisch veranderbaar voor deze persoon, gegeven profiel en context?
- c) **Netwerkimpact:** beïnvloedt de predictor meerdere criteria tegelijk (hogere return-on-intervention)?

Het bipartiet netwerk lezen:

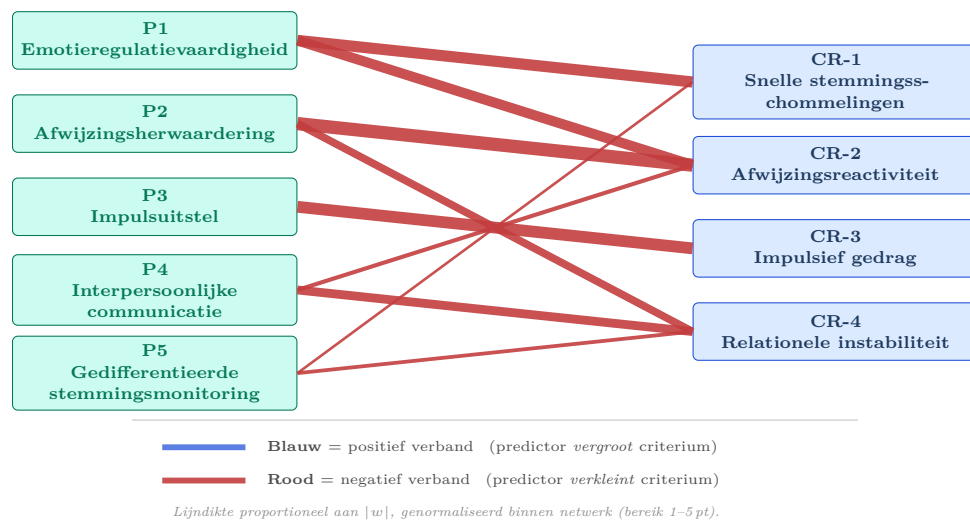
- Predictoren staan in de **linkerkolom (groen)**; criteria in de **rechterkolom (blauw)**.
- **Blauwe rand:** predictor heeft een positief verband met het criterium (hogere predictor → hoger criterium; bijv. meer veiligheidsgedrag → meer angst).
- **Rode rand:** predictor heeft een negatief verband met het criterium (hogere predictor → lager criterium; bijv. meer exposure → minder vermijding).
- **Lijndikte:** proportioneel aan de sterkte van het empirische verband (21-daagse EMA-data).

Antwoordformat: vul alle 5 prioriteitslijnen in, van rangorde 1 (hoogste prioriteit) tot en met 5 (laagste prioriteit).

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 3

Snelle stemmingsschommelingen, uitgesproken afwijzingsreactiviteit, impulsief gedrag en relationele instabiliteit. Duur: 3 jaar.

21-daagse monitoring: Dagelijks stembereik: gem. 5,8 punten. Emotieregulatievaardigheden gebruikt: gem. 1,2/dag. Impulsieve handelingen: gem. 2,1/dag. Interpersoonlijke conflicten: gem. 3,8/week. Ervaren afwijzingssignalen: gem. 2,4/dag. Herwaardering voor reactie: gem. 0,7/dag.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Emotieregulatievaardigheid, P2: Afwijzingsherwaardering, P3: Impulsuutstel, P4: Interpersoonlijke communicatie, P5: Gedifferentieerde stemmingsmonitoring

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

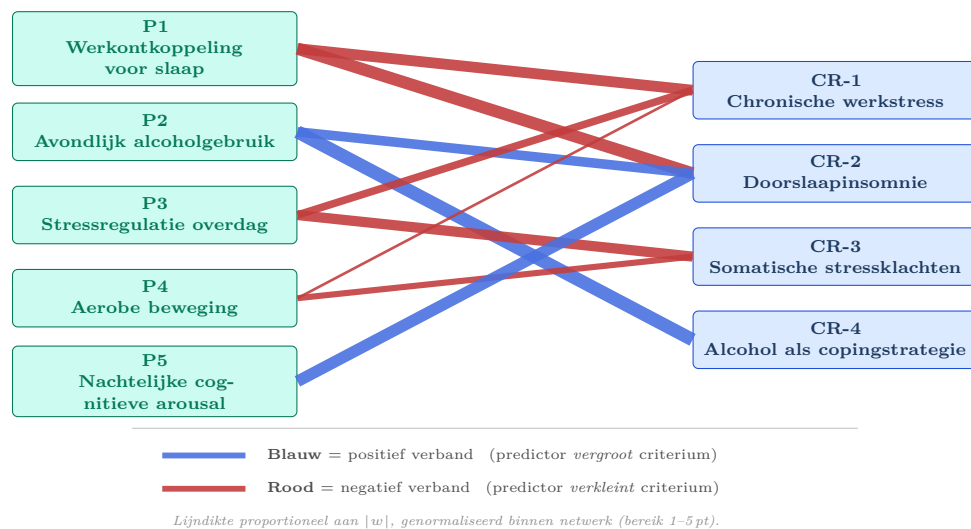
Prioriteit 4

Prioriteit 5

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 3

Chronische werkstress, doorslaapinsomnie, somatische stressklachten en alcoholgebruik als coping.
Duur: ongeveer 9 maanden.

21-daagse monitoring: Werkgerelateerde gedachten na 20.00 uur: gem. 3,4 uur. Alcoholeenheden in de avond: gem. 3,1. Hoofdpijndagen: 16/21. Slaapefficiëntie: gem. 62%. Stressregulatie overdag: gem. 0,9/dag. Lichamelijke activiteit: gem. 0,4 sessies/week.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Werkontkoppeling voor slaap, P2: Avondlijk alcoholgebruik, P3: Stressregulatie overdag, P4: Aerobe beweging, P5: Nachtelijke cognitieve arousal

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel – selectie van sub-predictoren

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 6 EMA-items: 2 sub-predictoren per behandeldoel** (3 behandeldoelen $\times$ 2 = 6 items).

Wat zijn sub-predictoren? Een behandeldoel uit Deel 3 (bijv. “geplande exposure”) is een conceptueel label. In de volgende EMA-cyclus moet dit label vertaald worden naar *concrete, dagelijks meetbare gedragsitems* – de **sub-predictoren**. Elke sub-predictor is een specifieke operationalisering van het behandeldoel als dagelijkse EMA-vraag.

Voorbeeld: behandeldoel = *avondschermtijd* → sub-predictor 1: “smartphone-gebruik na 22.00 uur (min)” → sub-predictor 2: “schermvrij interval voor slapengaan (min)”

Belangrijk: alle 20 items in de lijst zijn **predictor-type EMA-items** (modificeerbare gedragingen en strategieën – *geen* symptomen of klachtdimensies). Uw taak is te selecteren welke 6 items het best aansluiten bij de 3 gestandaardiseerde behandeldoelen, 2 per doel.

Selectieprincipe:

- Kies per behandeldoel de 2 items die dat doel het meest direct en precies meten.
- Verkies items die samen een compleet beeld geven van het behandeldoel (bijv. frequentie *en* duur, of twee complementaire gedragingen).
- Vermijd items die het behandeldoel slechts zijdelings raken.

Antwoordformat: vink **exact 6** items aan. Geen toelichting vereist.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Emotieregulatievaardigheid** (*laag gebruik ondanks groot stembereik; meest directe hefboom voor stabilisatie*)
2. **Impulsuitstel** (*impulsieve handelingen komen frequent voor en voeden relationele schade*)
3. **Afwijzingsherwaardering** (*grootste kloof tussen ervaren afwijzing en voorafgaande cognitieve bijsturing*)

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname na 14.00 uur (aantal)
2. ☐ Emotieregulatietechniek (bijv. grounding, ademhaling) bewust ingezet (ja/nee)
3. ☐ Consistent slaap- en waktijdstip aangehouden (ja/nee)
4. ☐ Aantal keer een bewuste emotieregulatievaardigheid ingezet vandaag (aantal)
5. ☐ Sociale media gebruik bewust beperkt of uitgesteld (min)
6. ☐ Maaltijdmoment op vaste tijd bewust aangehouden (ja/nee)
7. ☐ Impulsieve actie bewust uitgesteld of niet ondernomen (ja/nee)
8. ☐ Ontspanningsoefening of grondingsoefening uitgevoerd (min)
9. ☐ Alcoholinname vandaag (eenheden)
10. ☐ Wachtijd aangehouden voor impulsieve beslissing of actie (min)
11. ☐ Lichaamsbeweging of sport als spanningsafvoer vandaag (min)
12. ☐ Stemmingdagboek of patroonnotitie bijgehouden voor zelfbewustzijn (ja/nee)
13. ☐ Ervaren afwijzing bewust herwaardeert via een alternatieve interpretatie (ja/nee)
14. ☐ Bewuste onderbreking van oplopende spanning via een vaste pauze (ja/nee)
15. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
16. ☐ Alternatieve verklaring voor een afwijzingssignaal bewust geformuleerd (ja/nee)
17. ☐ Sociale media gebruik na werk bewust begrensd (min)
18. ☐ Bewust gecommuniceerd over behoeften of grenzen in een relatie (ja/nee)
19. ☐ Bewuste keuze om een conflict niet te escaleren (ja/nee)
20. ☐ Waterinname vandaag (glazen)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Werkontkoppeling voor slaap** (*momenteel afwezig en direct relevant voor doorslaapinsomnie*)
2. **Avondlijk alcoholgebruik** (*gemiddeld 3,1 eenheden per avond; onderhoudt slaapfragmentatie*)
3. **Stressregulatie overdag** (*laag maar trainbaar; upstream aangrijpingspunt voor CR-1 en CR-3*)

Opdracht: selecteer **exact 6** EMA-items (2 per behandeldoel) die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Consistent slaap- en waktijdstip aangehouden (ja/nee)
2. ☐ Werkapparaten bewust uitgeschakeld voor slapengaan (ja/nee)
3. ☐ Ontspanningsoefening in avondroutine als overgang van werk naar slaap (min)
4. ☐ Werkontkoppelingsritueel consequent gevolgd na 21.00 uur (min)
5. ☐ Vergadertijd of werkbelasting bewust begrensd vandaag (ja/nee)
6. ☐ Bewuste pauze of stressreductie-activiteit in de namiddag genomen (min)
7. ☐ Alcoholeenheden geconsumeerd na 19.00 uur (aantal)
8. ☐ Stretching of ontspanningsoefening in de ochtend uitgevoerd (min)
9. ☐ Cafeïne-inname na 16.00 uur bewust beperkt (ja/nee)
10. ☐ Avond zonder alcoholinname bewust aangehouden (ja/nee)
11. ☐ Aerobe beweging of sport als weekactiviteit uitgevoerd (min)
12. ☐ Avondmaaltijd op vaste tijd en bewust bereid genuttigd (ja/nee)
13. ☐ Stressregulatietechniek (ademhaling, mindfulness) bewust ingezet overdag (ja/nee)
14. ☐ Bewust contact met gezin of vrienden gezocht als herstellmiddel (ja/nee)
15. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
16. ☐ Duur bewuste stressverlichtende activiteit overdag (min)
17. ☐ Werkgerelateerde communicatie na 20.00 uur bewust uitgesteld of vermeden (ja/nee)
18. ☐ Schermtijd voor ontspanning na 21.00 uur bewust begrensd (min)
19. ☐ Dankbaarheidsnotitie of positieve dagstarter uitgevoerd (ja/nee)
20. ☐ Waterinname als dagelijks welzijnsgebruik (glazen)

Totaal geselecteerd: _____ / 6

6 Deel 5: Gepersonaliseerde mobiele coachingsboodschap (HAPA-kader)

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, rechtstreeks tot de persoon gerichte coachingsboodschap die in de mobiele applicatie verschijnt.

Theoretisch kader – HAPA: PHOENIX gebruikt het **Health Action Process Approach (HAPA; Schwarzer, 1992)** om de boodschap af te stemmen op de motivationele fase van de persoon:

- **Pre-intentionele fase:** de persoon is nog niet gemotiveerd om te veranderen → focus op risicobewustzijn en uitkomstverwachting.
- **Intentionele fase:** de persoon wil veranderen maar heeft nog geen concreet plan → focus op doelstelling en actieplanning.
- **Actie-/onderhoudsfase:** de persoon probeert al te veranderen → focus op copingplanning en zelfeffectiviteitsondersteuning.

U hoeft de fase niet expliciet te benoemen; gebruik het kader om de toon en inhoud van uw boodschap te sturen.

De boodschap voldoet aan:

- **Lengte:** 2–4 zinnen, compact genoeg voor een mobiel scherm.
- **Toon:** warm, direct, professioneel – geen klinisch jargon of diagnostische labels.
- **Inhoud:** adresseert het primaire behandeldoel en de voornaamste barriere; bevat een concrete, eerstvolgende actie.
- **Perspectief:** tweede persoon (“jij” of formeel “u”).

Werkvoorbeeld (niet gerelateerd aan een studiecaser):

Context: verpleegkundige; behandeldoel = korte beweegmomenten inbouwen; barriere = vermoeidheid na de shift (lage zelfeffectiviteit); fase = intentioneel.

Voorbeeldboodschap:

“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten – niet meer dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 5

Primair probleem

Snelle stemmingswisselingen en hevige reactiviteit leiden tot impulsieve beslissingen en relationele escalatie.

Behandeldoel

Een specifieke emotieregulatievaardigheid inzetten zodra spanning begint op te lopen.

Voornaamste barriere

Lage coping-self-efficacy: in het piekmoment verwacht de persoon dat vaardigheden toch niet zullen werken.

Copingstrategie

Gebruik een vooraf geoefende cue-actie-koppeling: herken een vroege lichamelijke cue en koppel die aan exact een vaardigheid.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 5**Primair probleem**

Aanhoudende werkstress leidt tot gefragmenteerde slaap, lichamelijke spanningsklachten en alcohol als vaste ontladingsstrategie.

Behandeldoel

Een korte werkontkoppelingsroutine installeren en alcohol niet langer als standaard afschakelmechanisme gebruiken.

Voornaamste barriere

Sterke gewoontekracht: alcohol voelt essentieel om de overgang van werk naar slaap te maken.

Copingstrategie

Vervang het bestaande gewoontepatroon door een vast, tijdsgebonden afbouwritueel dat elke avond op hetzelfde moment start.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 6 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-05

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.